Manuel de prévention des infections associées aux soins

Reference	IPC-MAN-01 v6
Owner	Équipe opérationnelle d'hygiène
Approved by	Quality and Patient Safety Committee
Effective date	20/04/2026
Next review	20/04/2029
Applies to	All clinical areas of the Centre Hospitalier Saint-Aubin

1. Précautions standard

L'hygiène des mains, le port de gants pour tout risque d'exposition à des liquides biologiques, la gestion des excreta et le bionettoyage s'appliquent à tous les patients, quel que soit leur statut infectieux.

2. SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline)

Dépistage. Les patients transférés d'un autre établissement ou venant d'un établissement d'hébergement sont dépistés à l'admission (nez et périnée).

Statut du dépistage	Mesure
Positif	chambre individuelle et précautions contact jusqu'à la levée
En attente, patient transféré d'un autre établissement	chambre individuelle et précautions contact dès l'admission, en attente du résultat
En attente, autre provenance	précautions standard
Négatif	précautions standard

Décolonisation. Mupirocine nasale trois fois par jour et toilette à la chlorhexidine 4 % une fois par jour pendant **5 jours**. **Contrôle.** Trois séries de prélèvements sur des jours différents ; la première au moins **48 heures après la fin** de la décolonisation. Les précautions contact sont maintenues jusqu'à trois séries négatives.

3. Clostridioides difficile

Chambre individuelle avec sanitaires dédiés, lavage des mains à l'eau et au savon (la solution hydro-alcoolique est insuffisante), précautions contact jusqu'à 48 heures après la normalisation des selles.

4. Governance, audit and training

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

5. Revision history

Version	Date	Author	Summary of change
1.0	20/04/2021	Équipe opérationnelle d'hygiène	First issue
2.0	20/04/2023	Équipe opérationnelle d'hygiène	Triennial review; format harmonised
3.0	20/06/2025	Équipe opérationnelle d'hygiène	Tables updated after clinical audit
current	20/04/2026	Équipe opérationnelle d'hygiène	Review and re-issue

Annex A. Implementation notes

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Annex B. Implementation notes

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Annex C. Implementation notes

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

Annex D. Implementation notes

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

La conformité est évaluée par le service d'audit clinique sur un échantillon glissant de dossiers. Les résultats sont présentés à la commission qualité et sécurité des soins qui convient des actions avec les cadres de santé.

Tout professionnel qui constate un écart par rapport à ce document, ou une situation non couverte, en parle au senior de garde et le signale dans le système de déclaration des événements indésirables, dans une démarche d'apprentissage.

Le pilote du document le révise au moins tous les trois ans, ou plus tôt si une recommandation nationale, un événement indésirable grave ou un audit l'exigent. Les modifications intermédiaires sont validées par le président de l'instance concernée.

Ce document est maîtrisé. Les copies imprimées ne sont pas maîtrisées : la version en vigueur est conservée dans la gestion documentaire de l'établissement et toute copie papier doit être vérifiée avant usage.